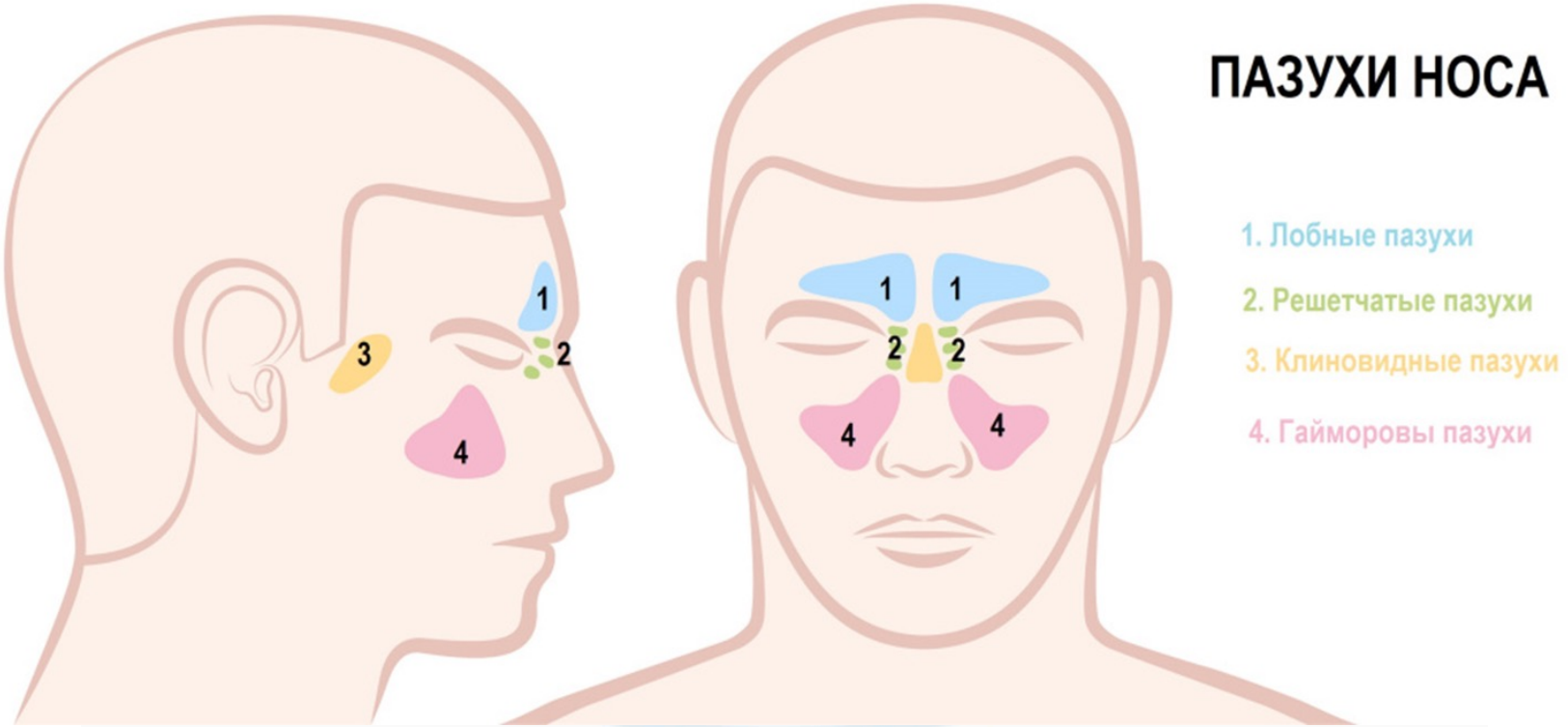
1

Дыхательная система

Заболевания органов дыхания

Синусы — это воздухоносные полости в костях черепа, соединённые с полостью носа. Основные синусы:

- гайморовы (верхнечелюстные)
- лобные (фронтальные)
- решётчатые
- клиновидные



Функции синусов

1. Увлажнение и согревание воздуха .Слизистая синусов и носа подготавливает воздух для дыхательных путей.
2. Фильтрация воздуха. Слизь задерживает вирусы, бактерии и пыль.
3. Облегчение веса черепа. Полости содержат воздух, делая кости легче.
4. Формирование голоса (резонанс). Синусы усиливают звучание голоса.
5. Защита (амортизация). Воздушные полости смягчают удар при травмах лица

Синусит — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.

Основные виды:

- Гайморит — воспаление гайморовых пазух
- Фронтит — воспаление лобных пазух

Симптомы синусита

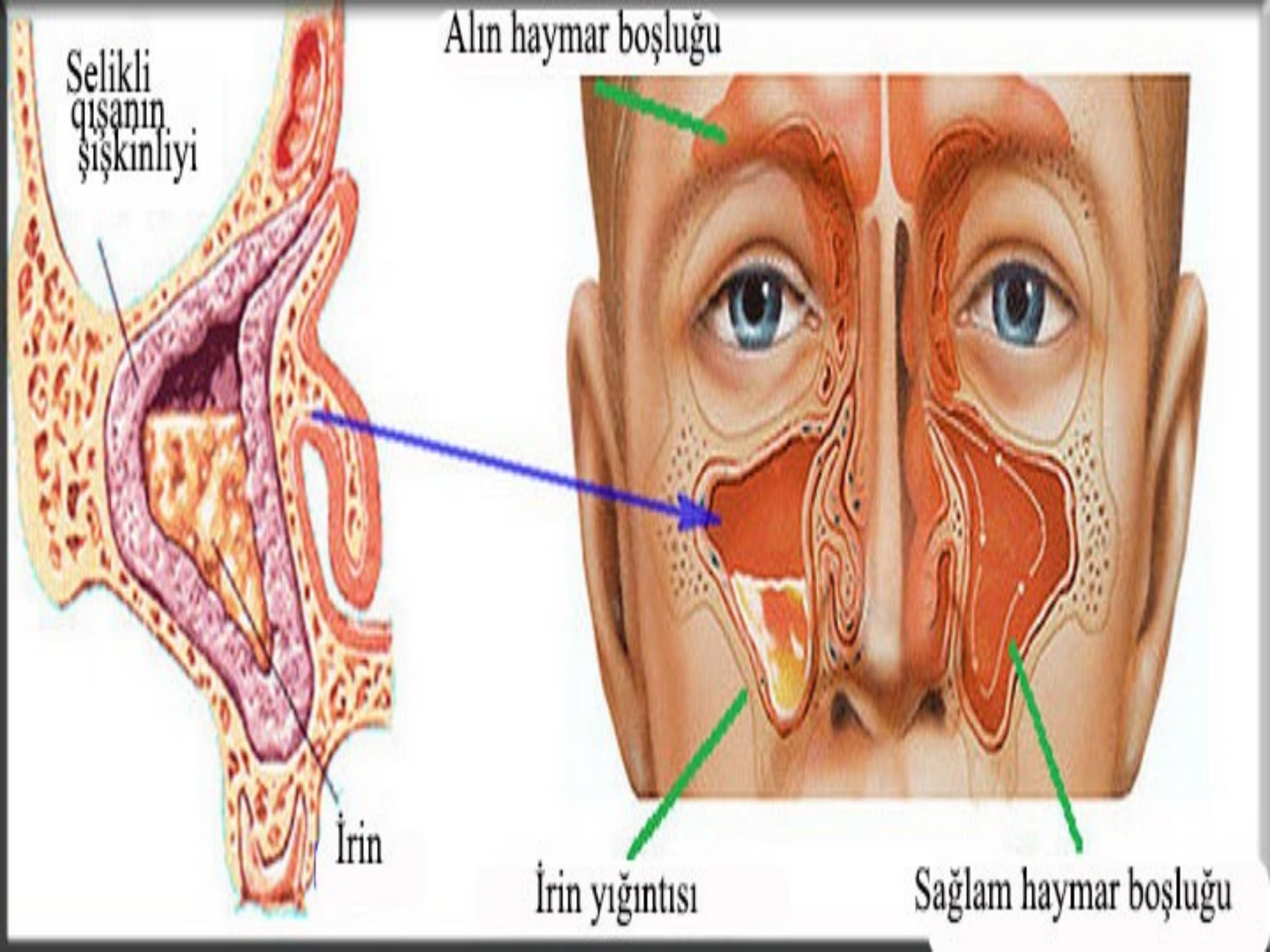
- заложенность носа
- затруднённое носовое дыхание
- головная боль, тяжесть в области пазух
- боль при наклоне головы
- слизисто-гнойные выделения
- снижение обоняния
- температура (чаще при бактериальном процессе)

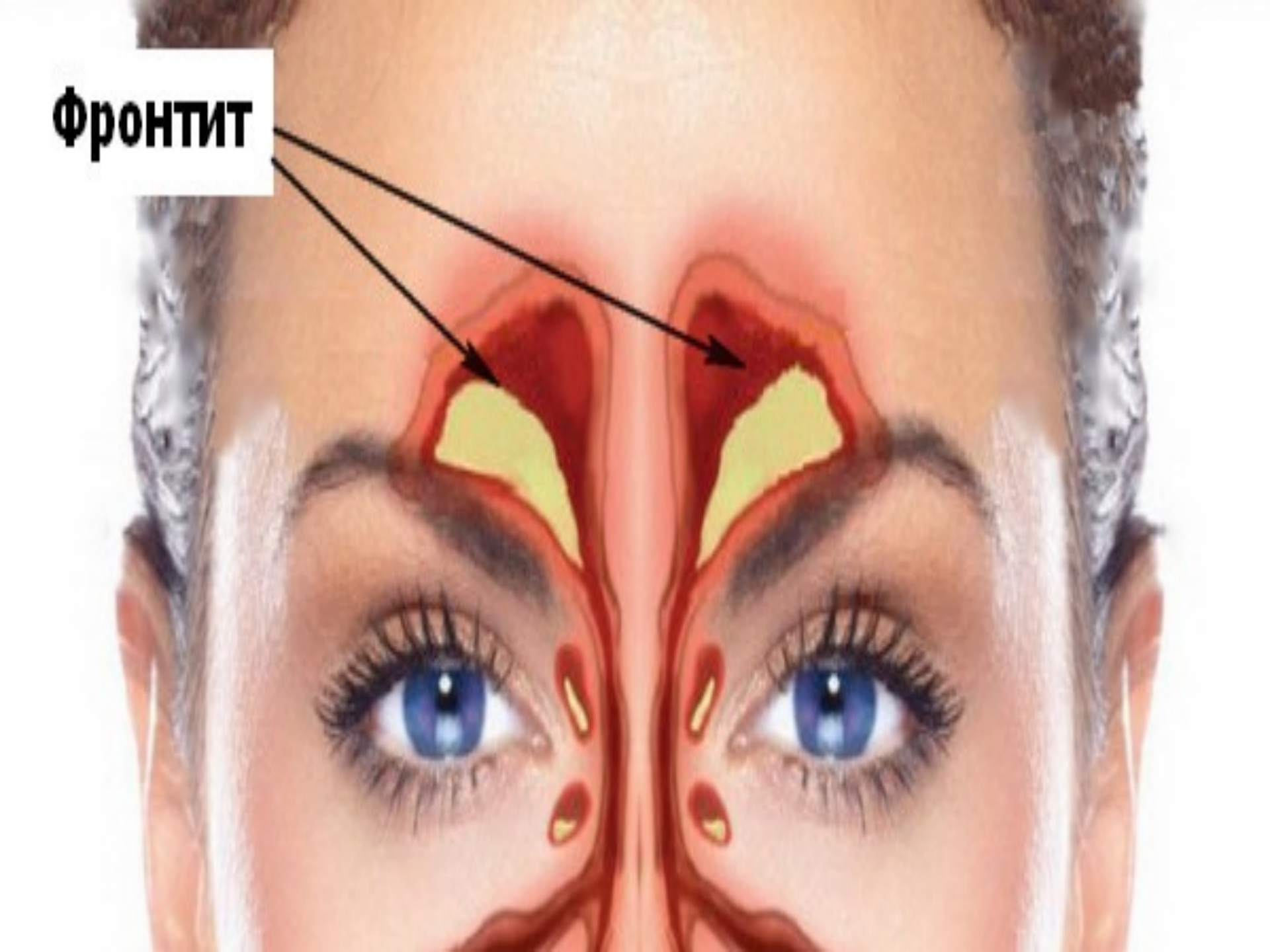
Тонзиллит — это воспаление нёбных миндалин (гланд).
Может быть острым (ангина) или хроническим.
Миндалины — это часть иммунной системы.
Они состоят из лимфоидной ткани и выполняют функции:

- защищают организм от вирусов и бактерий, попадающих через рот и нос
- содержат лимфоциты и фагоциты — клетки, которые убивают микробы
- являются «первой линией обороны» дыхательных путей
- участвуют в формировании иммунитета у детей

Нёбные миндалины (гланды) находятся:

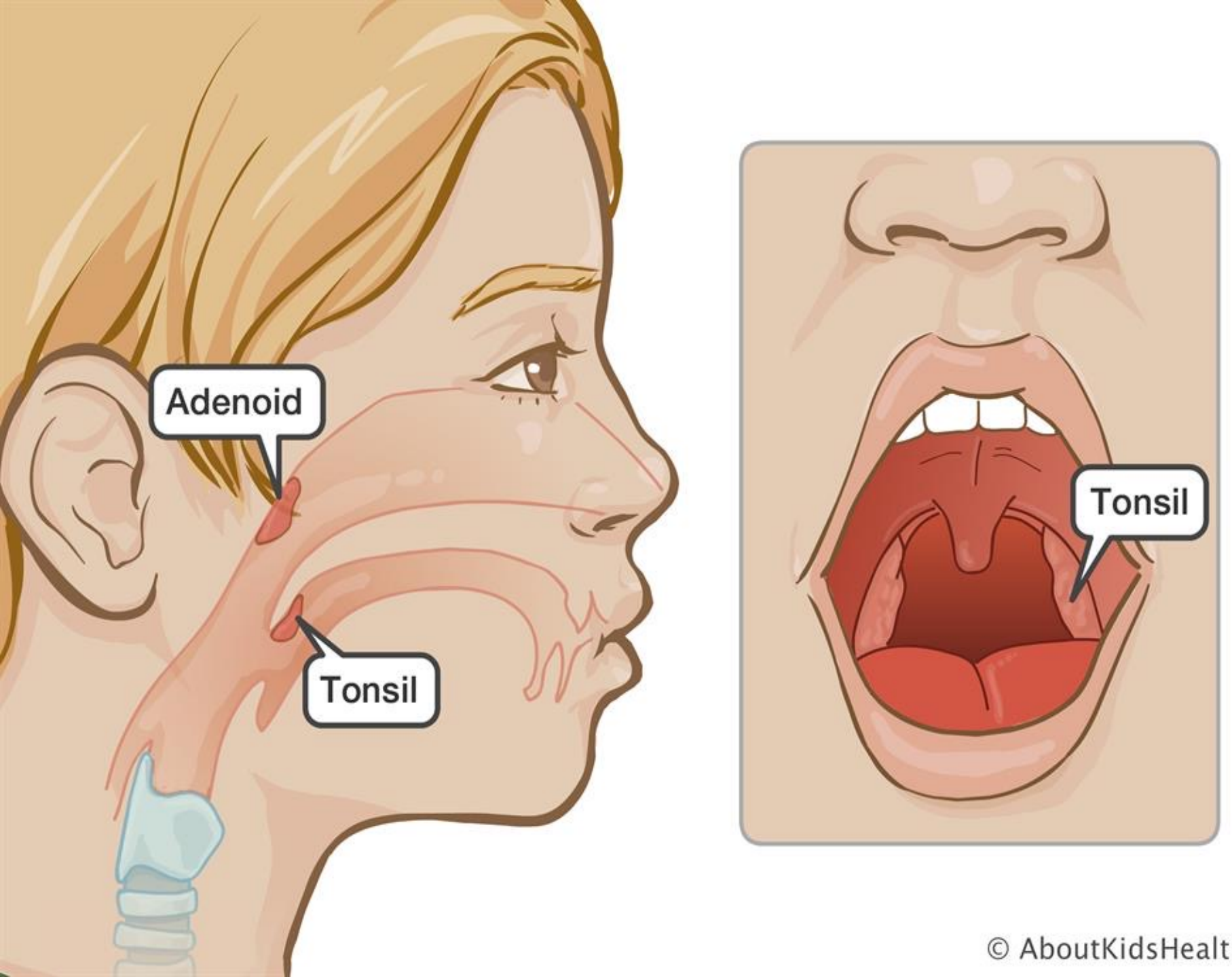
- в ротоглотке,
- по обеим сторонам зева,
- между передней и задней нёбными дужками.


Selikli qışanın şişkinliyi
İrin
Alın haymar boşluğu
İrin yığıntısı
Sağlam haymar boşluğu


Фронтит

Аденоид — это увеличение и разрастание лимфоидной ткани в области перехода носовой полости в носоглотку. При выраженной гипертрофии аденоид может значительно суживать просвет носоглотки и затруднять носовое дыхание, вызывая храп, частые простуды и снижение слуха. Чтобы предотвратить прогрессирование аденоидита и тонзиллита, важно своевременно проводить лечение — консервативное (без операции), или же хирургическое (если изменения сильно выражены)

- Ангина — острое воспаление нёбных миндалин.
- Ларингит — воспаление слизистой гортани.
- Бронхит — воспаление бронхов
- Трахеит — воспаление трахеи



© AboutKidsHealth.ca

Бронхиальная астма – это хроническое неинфекционное заболевание дыхательных путей воспалительного характера. Приступ бронхиальной астмы часто развивается после предвестников и характеризуется коротким резким вдохом и шумным длительным выдохом. Обычно он сопровождается кашлем с вязкой мокротой и громкими свистящими хрипами. Методы диагностики включают оценку данных спирометрии, пикфлоуметрии, аллергопроб, клинических и иммунологических анализов крови. В лечении используются аэрозольные бета-адреномиметики, м-холинолитики, при тяжелых формах заболевания применяются глюкокортикостероиды.

Наиболее опасными провоцирующими факторами для развития бронхиальной астмы являются экзогенные аллергены. Самыми распространенными аллергенами являются бытовые аллергены – это домашняя и книжная пыль, пыльца растений, шерсть, перхоть животных, аллергены растительного происхождения и пищевые аллергены. Инфекционные факторы тоже являются важным звеном в этиопатогенезе бронхиальной астмы, так как микроорганизмы, продукты их жизнедеятельности могут выступать в качестве аллергенов, вызывая сенсибилизацию организма. Такие факторы, как переохлаждение, отягощенная наследственность и стрессовые состояния тоже занимают одно из важных мест в этиологии бронхиальной астмы

Основные симптомы астмы

- свистящие хрипы
- эпизодическая одышка
- кашель, особенно ночью и под утро
- чувство тяжести и давления в груди
- затруднённый выдох
- приступообразность
- усиление симптомов на холоде, при контакте с аллергеном, после нагрузки

Опасные признаки (повод срочно вызвать скорую)

- выраженная одышка
- посинение губ и кожи (цианоз)
- затруднённый вдох и выдох
- учащённый пульс, холодный пот
- ощущение паники
- отсутствие эффекта от ингалятор